

チェックポイント阻害薬（ICI）や ICI+抗癌薬治療での良好な効果が複数報告され期待されている^{43,44)}。

10

唾液腺型腫瘍

salivary gland-type tumors

到達目標

- 唾液腺型腫瘍の分類・定義・診断法が説明できる
- 唾液腺型腫瘍に含まれる各腫瘍の特徴を理解する

気管、気管支、肺から発生する唾液腺腫瘍に類似した腫瘍。WHO 分類第5版では、粘表皮癌、腺様嚢胞癌、上皮-筋上皮癌、多型腺腫、硝子化明細胞癌、筋上皮腫/筋上皮癌が挙げられている¹⁾。後四者は極めてまれな腫瘍である。前二者は区域気管支までの中枢気管支に発生することが多く、CTなどの画像所見としては、気管支の狭窄や腔内腫瘍像がみられることもあるが、画像所見では無気肺や二次的な浸潤影を契機に発見されることが多いとされる。放射線治療の感受性は低いとする報告もあり、化学療法に関するまとまった報告もなく、可及的に外科的切除が推奨される⁴⁵⁾。

a 粘表皮癌 (mucoepidermoid carinoma)

30～40歳代に好発。中枢気管支に発生する。低悪性度腫瘍が大部分を占める。粘液産生細胞、扁平上皮細胞、中間細胞で構成される¹⁾。高悪性度の粘表皮癌はまれであるが、腺扁平上皮癌との鑑別は必ずしも容易ではない。CRTC1-MAML2融合遺伝子がみつかることが多く、診断に有用である。EGFR 遺伝子変異の報告もあるが意義は不明である。

b 腺様嚢胞癌 (adenoid cystic carcinoma)

40～50歳代に好発。中枢気管支に発生する。導管上皮様細胞と筋上皮細胞から構成される篩状、管状、充実状構造が混在する。粘膜下での浸潤傾向は強く、神経周囲浸潤が目立つ¹⁾。腫瘍性筋上皮細胞にはCD117 (KIT) の発現がしばしばみられるがC-KIT変異は認められない。EGFR、RAS変異は同定されていない。ほとんどの症例でMYB-NFIB融合遺伝子が認められる。比較的緩徐な増大を示すことが多い。

c 上皮-筋上皮癌 (epithelial-myoepithelial carcinoma)

30～70歳に発生。中枢気管支に発生。低悪性度唾液腺型腫瘍であり、唾液腺の介在導管部に類似した内層を形成する円柱状上皮細胞と外層の筋上皮細胞の二相性配列を示す腺管形成を特徴とする¹⁾。唾液腺や乳腺に発生することが多く、気管支原発は極めてまれとされる。EGFR、RAS変異は同定されていない。

d 多形腺腫 (pleomorphic adenoma)

幅広い年齢層に発生する。中枢気管支内に発生。上皮細胞、筋上皮細胞、軟骨様基質からなる腫瘍で、通

常は良性¹⁾。唾液腺ではありふれた腫瘍であるが、肺では非常にまれである。

e 硝子化明細胞癌 (hyalinizing clear cell carcinoma)

成人の中枢気管支に発生する極めてまれな腫瘍でWHO 分類第5版で初めて追加された組織型である。比較的境界明瞭な淡褐色腫瘍を形成し、淡明ないしは淡好酸性の細胞質を有する低異型度の上皮細胞からなる腫瘍で、硝子様・粘液腫状・線維性の間質を伴う。免疫組織学的にはCK7や高分子量サイトケラチン(34βE12)、CK5/6、p63、p40が陽性となる。TTF-1やnapsin A、CK20、S100は陰性である。EWSR1-ATF1融合遺伝子がすべての症例で検出されている。

f 筋上皮腫 / 筋上皮癌 (myoepithelioma / myoepithelial carcinoma)

筋上皮腫は胸郭内に発生した良性的筋上皮性腫瘍で、筋上皮癌は悪性の筋上皮性腫瘍である。半数は中枢側気管支や気管に発生するが、肺実質内や、胸壁、縦隔、心臓に発生することもある。索状、網状、胞巣状、充実性に増殖する筋上皮性腫瘍細胞が粘液腫状、軟骨様、硝子様の間質を伴いながら増殖する。ケラチン、EMA、S100が陽性となり、EWSR1またはFUSの転座が検出されることがある。筋上皮癌では筋上皮腫よりも高度の核異型や核分裂像の増加、壊死などを呈する。他臓器からの転移の除外が必須である。

文 献

- 1) 日本肺癌学会（編）：臨床・病理 肺癌取り扱い規約、第9版、金原出版、2025
- 2) Izumchenko E, et al : Nat Com 6 : 8258, 2015
- 3) Merrick DT, et al : Cancer Res 78 : 4971, 2018
- 4) 国立がん研究センター がん情報サービス 最新がん統計 https://ganjoho.jp/reg_stat/index.html
- 5) 澤端章好ほか：肺癌 50 : 875, 2010
- 6) 新 WHO 分類に準拠した病理組織分類
- 7) Minami Y, et al : Lung Cancer 48 : 339, 2005
- 8) 日本肺癌学会（編）：肺癌診療ガイドライン 2025 年版—悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍を含む
- 9) 国立がん研究センター がん情報サービス 肺がん <https://ganjoho.jp/public/cancer/lung/index.html>
- 10) 日本臨床検査医学会：臨床検査のガイドライン 2005/2006 https://www.jslm.org/books/guideline/05_06/298
- 11) Luis Paz-Ares, et al. N Engl J Med 379 : 2040, 2018
- 12) Mertin Reck, et al. N Engl J Med 375 : 1823, 2016
- 13) Tsuchiya R, et al : J Thorac Cardiovasc Surg 129 : 977, 2005
- 14) Takada M, et al : J Clin Oncol 20 : 3054, 2002
- 15) Cheng Y, et al : N Engl J Med 391 : 1313, 2024
- 16) Fukuoka M, et al : J Natl Cancer Inst 83 : 855, 1991
- 17) Noda K, et al : N Engl J Med 346 : 85, 2002
- 18) Horn L, et al : N Engl J Med 379 : 2220, 2018
- 19) Paz-Ares L, et al : Lancet 394 : 1929, 2019
- 20) Okamoto H, et al : Br J Cancer 97 : 162, 2007
- 21) Asano T, et al : Lancet Respir Med 13 : 1057, 2025
- 22) Aupérin A, et al : N Engl J Med 341 : 476, 1999
- 23) Nosaki K, et al : Radiother Oncol 127 : 344, 2018
- 24) von Pawel J, et al : J Clin Oncol 32 : 4012, 2014